Manejo del dolor en el embarazo

Manejo del dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Migraña y embarazo

4. Dolor músculoesquelético en la gestante

5. Dolor neuropático en la gestante

6. Dolor crónico en la gestante y riesgos/beneficios de la medicación

Amitriptilina
Gabapentina
Pregabalina
Duloxetina
Tramadol
Morfina
Oxicodona
Crema de capsaicina 0,075 %
Parche de capsaicina 8 %
Parche lidocaína 5 %

7. Conclusiones

8. Referencias bibliográficas

Objetivos

1. Cómo diagnosticar y tratar los diferentes tipos de dolor que desarrolla más frecuentemente la gestante: la migraña, el dolor lumbar y pélvico, el síndrome del túnel del carpo, así como la meralgia parestésica.
2. Orientar para el manejo terapéutico del dolor crónico en la gestante.
3. Describir los riesgos y beneficios de la medicación analgésica en la gestante.

Introducción

El dolor en la paciente embarazada puede ser por múltiples causas y su tratamiento va a suponer todo un desafío para el especialista, considerando que si la paciente no recibe el tratamiento adecuado afectará de forma negativa tanto a la madre como al feto, alterando su desarrollo y crecimiento. *(Ver figura 1)*

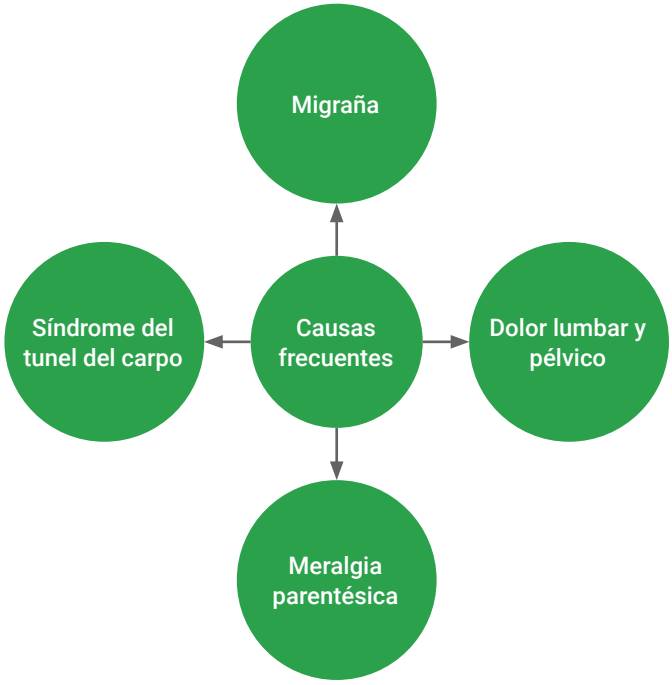

Figura 1. Causas más frecuentes de dolor en la gestante. Tomado de: Tech (s.f.).

La cefalea es uno de los motivos más frecuentes de consulta en neurología. Es relevante dedicarle atención a la que aparece durante el embarazo, pues es en la edad fértil de la mujer cuando ésta es más prevalente. Se debe conocer bien cómo se comportan las cefaleas primarias durante el embarazo además de poder descartar la presencia de una cefalea secundaria, cuya frecuencia se incrementa en este grupo de población (1).

El dolor lumbar es una de las condiciones musculo-esqueléticas más frecuentes a nivel mundial, con una prevalencia entre un 60 % a 90 % de la población. El dolor lumbopélvico (DLP) durante el embarazo es definido como dolor intermitente o continuo, que se ubica en la región lumbar y/o cinturón pélvico, mayor a una semana, afectando a un 50 a 70 % de las mujeres, siendo mucho más prevalente en este periodo. Su aparición ocurre alrededor de la semana 18° y la máxima intensidad entre la 24° a 36°. En la mayoría de los casos hay una recuperación al mes o tres meses postparto. Sin embargo, estudios reportan que la mejoría es incompleta, por lo que puede persistir o aumentar años después del parto.

La literatura reporta que cuadros de DLP previos al embarazo, la paridad y el sobrepeso u obesidad, son los principales factores de riesgo para el desarrollo de DLP en el embarazo. Las causas se relacionan con los cambios fisiológicos normales durante el embarazo tales como el aumento de masa corporal, la postura alterada por aumento de la lordosis compensatoria al aumento del tamaño del abdomen, la laxitud ligamentosa causada por la hormona relaxina, los cambios de presión intraabdominal e intrauterina y la retención de fluido dentro del tejido conectivo; por lo que se considera una condición multifactorial (2).

Migraña y Embarazo

La migraña es un trastorno de cefalea primaria episódico que afecta 1 de cada 9 adultos en todo el mundo. El subtipo más prevalente es la migraña sin aura, cuyos principales síntomas son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Los ataques de migraña no tratados o tratados sin éxito pueden durar de 4 a 72 horas y puede requerir reposo en cama (3).

La migraña es una enfermedad cuya historia natural está condicionada por los cambios hormonales. De hecho, la prevalencia es similar en niños y niñas antes de la menarquía y posteriormente aumenta en la mujer. Por lo tanto, el embarazo y la lactancia se cree que ejercen un efecto modulador, que podría mejorar la frecuencia de migraña o incluso desaparecer. Estos cambios se relacionan con las modificaciones que ocurren durante el embarazo en los niveles de estrógenos y progesterona, que se incrementan, pero permanecen estables a diferencia de las fluctuaciones tan marcadas que suceden fuera del embarazo. *(Ver figura 2)*

En general, la mayoría de las mujeres mejorarán durante la gestación, aunque dicha premisa no se cumple tanto en las formas crónicas o con aura. La mejoría es más marcada en los dos últimos trimestres y el porcentaje de recurrencia tras el parto es hasta del 90 %. La migraña de debut en el embrazo es poco frecuente, si esto ocurre suele ser durante el primer trimestre. Cabe resaltar que la gestación puede resultar una época de mayor estrés, clásico desencadenante de crisis de migraña, y hay que manejar también este aspecto. A la lactancia materna se le atribuye también un papel protector por mantener estables los niveles estrogénicos, así como niveles de prolactina y oxitocina que podrían actuar como moléculas antinociceptivas (1).

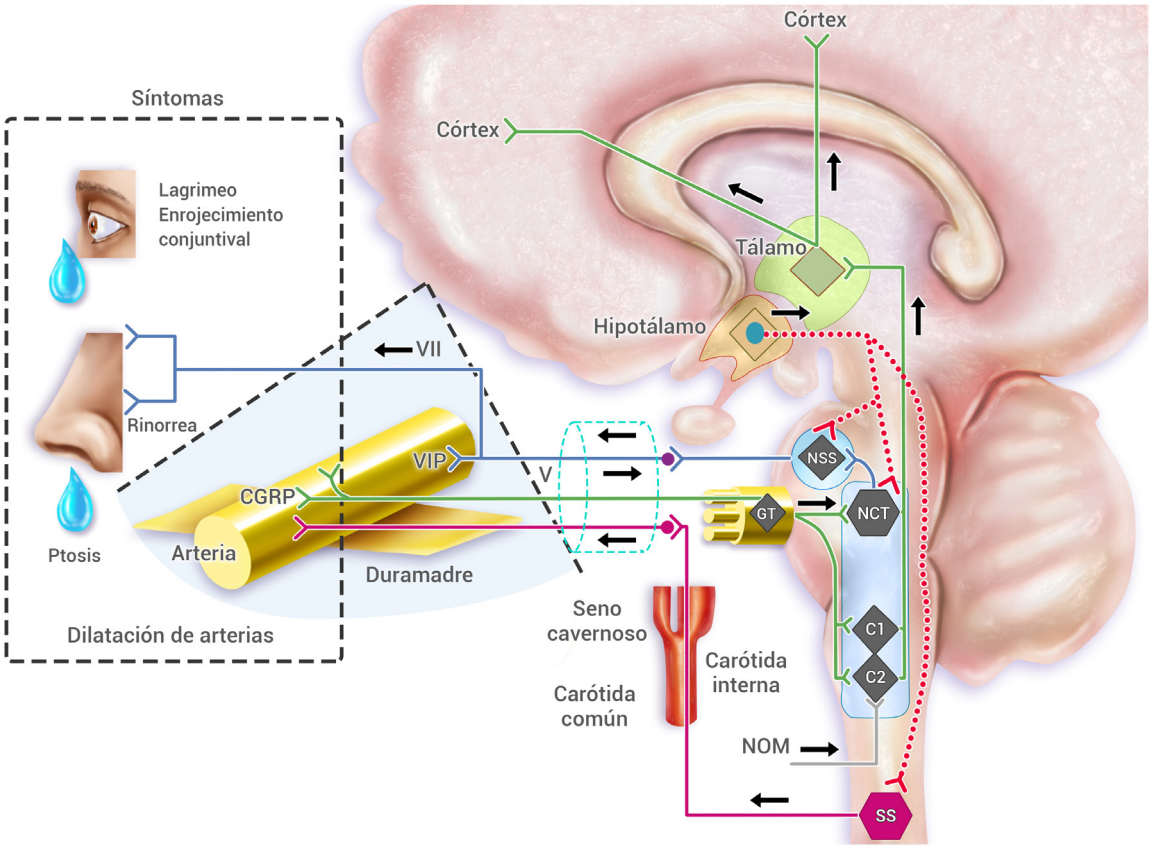

Figura 2. Etiopatogenia de la cefalea migrañosa. Tomado de: Migraña. Cuellar Rodríguez S. Panorama Actual Med [internet]. 2018.

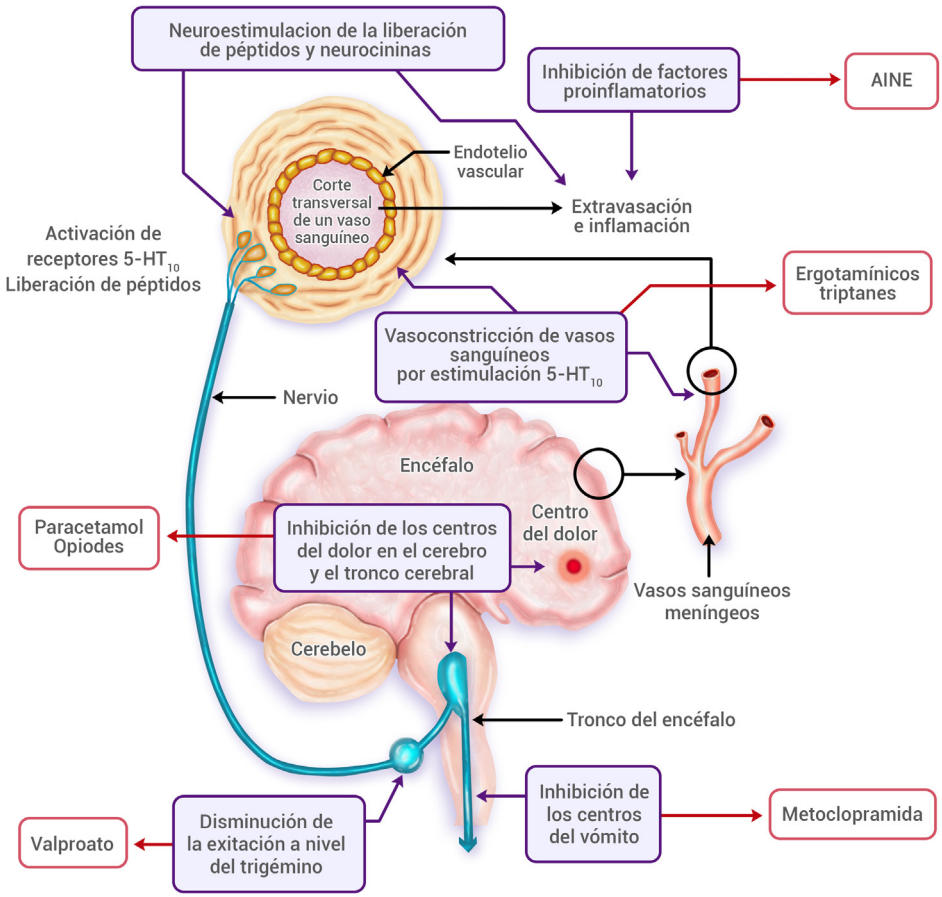

Figura 3. Mecanismo de acción de los fármacos empleados en el tratamiento de migraña. Tomado de: Migraña. Cuellar Rodríguez S. Panorama Actual Med [internet]. 2018.

La fase de dolor de cabeza de un ataque de migraña dependería de la sobreactivación de las vías de dolor trigéminovasculares y la liberación de neuropéptidos, como el péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP). Este proceso conduce a la activación y sensibilización de neuronas trigéminovasculares centrales de segundo orden y de tercer orden. Estas neuronas activan diferentes áreas del tallo encefálico y el cerebro anterior, lo que produce dolor y síntomas de migraña (3). *(Ver figura 3)*

Se disponen de pocos datos de seguridad de los fármacos en estas etapas, por las limitaciones éticas de realizar ensayos en estos periodos; aunque en general el manejo en estas pacientes no dista tanto de aquel fuera de la gestación, salvo algunas excepciones. También se debe considerar qué fármacos emplear en las pacientes en edad fértil, ante un posible embarazo no deseado. Las recomendaciones de esta guía se extraen de los últimos estudios de seguridad, consensos de expertos y registros más actuales del empleo de algunos fármacos durante el embarazo y la lactancia (1).

El objetivo del tratamiento de la migraña es conseguir la eliminación del dolor y del resto de síntomas asociados, y que el paciente pueda continuar sus actividades con normalidad, recuperando así su calidad de vida (4). Este tratamiento basa en los siguientes pilares fundamentales:

- Identificación y, si es posible, supresión o limitación de los factores modificables de riesgo.
- Control rápido de los síntomas y de la discapacidad, reduciendo la intensidad y acortando la duración de las crisis.
- Prevención de la recurrencia de las crisis.
- Evitar o limitar la incidencia de efectos adversos del tratamiento.

El tratamiento sintomático se estratificará según la gravedad de las crisis. En casos de crisis leves y moderadas se emplearán analgésicos simples, a ser posible paracetamol, por ser la molécula más segura tanto durante el embarazo como en la lactancia. La segunda línea de tratamiento serían los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), cuyo uso está permitido únicamente durante el segundo trimestre, por tener riesgo de teratogenia en el primero y riesgo de cierre precoz del ductus arterioso a partir de la semana 30. Son fármacos seguros durante la lactancia. En caso de crisis moderadas - graves, se recomiendan los triptanes. Siempre, si es posible, se debe elegir el sumatriptán por ser el que más años de experiencia y datos de seguridad tiene. Tampoco existen problemas de su uso durante la lactancia. Con relación a los coadyuvantes antieméticos, la metoclopramida es de primera elección durante el embarazo y lactancia. La domperidona se debe evitar, por riesgo de prolongación del QT. Otras opciones seguras serían la clorpromazina o combinaciones de doxilamina y piridoxina, que podrían emplearse también para el tratamiento del síndrome emético gestacional (5).

En pacientes con *status* migrañoso los bloqueos anestésicos son seguros y eficaces, permitiendo evitar la vía oral o parenteral. De entre todos los anestésicos locales se prefiere la lidocaína (clase B) aunque bupivacaína o mepivacaína también se pueden emplear por ser de uso periférico y a muy baja dosis. También se puede administrar de forma puntual diclofenaco parenteral o sumatriptán subcutáneo. La clorpromazina y metoclopramida intravenosa son opciones seguras en el embarazo y la lactancia. Los corticoides por vía parenteral, preferiblemente metilprednisolona, se utilizarán de forma puntual y si es posible siempre evitando el primer trimestre. También es compatible con la lactancia, aunque se debe esperar, entre 2 y 8 horas a la siguiente toma o realizar una extracción previa (1).

Cuando los ataques de migraña superan una frecuencia de más de 3 veces al mes, duran mucho tiempo o no responden adecuadamente a la medicación utilizada para aliviar las crisis de dolor, se recurre a un tratamiento preventivo. También puede plantearse tomar tratamiento preventivo una persona con una migraña mensual, pero que dura 2-3 días y le incapacita para desarrollar sus actividades, o aquella con migrañas leves pero muy frecuentes o cuando existen contraindicaciones de uso de determinados medicamentos para actuar contra las crisis, como los triptanes, o cuando los analgésicos convencionales no son efectivos.

El tratamiento preventivo no es curativo, pero puede reducir sustancialmente la frecuencia, la intensidad y/o la duración de las crisis migrañosas, y mejoran la respuesta al tratamiento sintomático; se considera que el tratamiento no es eficaz cuando no sea capaz de reducir al menos a la mitad la frecuencia de las crisis. El tratamiento preventivo se toma a diario durante períodos variables de tiempo, que oscilan entre 3 y 12 meses al año, aunque su efecto preventivo puede tardar hasta varias semanas en manifestarse. Los fármacos más ampliamente utilizados como preventivos de las crisis migrañosas son los indicados a continuación; todos ellos son de administración oral, salvo la toxina botulínica (IM) y suelen requerir un ajuste progresivo de la dosificación hasta alcanzar el equilibro óptimo entre eficacia y efectos adversos:

- Betabloqueantes: metoprolol (50-100 mg/12 h), propranolol (40-80 mg/12 h); también se utiliza el atenolol.
- Antiepilépticos: topiramato (50 mg/12 h), ácido valproico, gabapentina.
- Antagonistas del calcio: flunarizina (5-10 mg/24 h), cinarizina (75 mg/24 h).
- Toxina botulínica.
- Antidepresivos: amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina.
- Antihipertensivos: lisinoprilo, candesartan.

- Antagonistas serotonérgicos: pizotifeno, ciproheptadina.
- Otros fármacos: riboflavina (vitamina B2), ubiquinona (coenzima Q10).

El tratamiento preventivo debe iniciarse utilizando las dosis más bajas eficaces, que se incrementarán progresivamente hasta que se produzca una mejoría clínica, se alcance la dosis máxima recomendada o aparezcan efectos adversos intolerables. Posteriormente, cuando se produce una mejoría (habitualmente entre 3 y 12 meses de tratamiento), se podrá reducir progresivamente la dosis hasta suspender el fármaco preventivo. En algunos casos, es necesario mantener dosis bajas del fármaco por la reaparición de la cefalea cada vez que se intenta suspender (4).

Dolor músculoesquelético en la gestante

El embarazo es un periodo de profundos cambios anatómicos y fisiológicos, ya que la mujer grávida no solamente cumple la función de albergar el feto sino también se somete a adaptaciones corporales y hormonales. No es sorprendente que estas adaptaciones son capaces de derivar un conjunto de problemas, tales como artralgias, dolor lumbar, tendinitis y osteoporosis transitoria.

Durante el embarazo, la mujer usualmente aumenta de 25 a 35 libras (11 – 15 kg) cambia el centro de gravedad corporal y experimenta modificaciones biomecánicas en el esqueleto axial y la pelvis (6).

Algunos de los cambios más frecuentes son los siguientes:

- La fuerza sobre algunas articulaciones aumenta hasta el doble.
- Se produce un aumento significativo en la inclinación anterior de la pelvis, con mayor uso del extensor de la cadera, el abductor y los músculos flexores plantares del tobillo. Como consiguiente cambia el centro de gravedad por el aumento en la circunferencia abdominal. De forma compensatoria se adquiere una lordosis exagerada de la zona lumbar y cifosis cervical.
- La laxitud articular en los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna lumbar crea mayor inestabilidad en la columna lumbar y puede predisponer a la distención muscular.
- Se aumenta la movilidad de las articulaciones sacroilíacas y sínfisis púbica en preparación para el paso del feto a través del canal de parto.

El dolor lumbar se define como el dolor y la incomodidad localizados debajo del margen costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, con o sin dolor en las piernas. Básicamente, el lumbago es un término general para el dolor que se localiza en las regiones pélvicas o lumbares.

El lumbago es una de las causas de dolor más frecuente durante el embarazo y a menudo empeora a medida que este avanza. El dolor puede interrumpir las actividades diarias, el trabajo y el sueño de las embarazadas. También se ha visto que tiene un impacto potencial en el desarrollo fetal y crecimiento, por lo que el alivio del dolor beneficiaría tanto a la madre como al hijo.

Se estima que la prevalencia mundial de lumbago en la embaraza oscila entre el 24 % y el 90 %. El principal problema para determinar una prevalencia más certera es que no existe un sistema de clasificación universalmente reconocido para la condición, por lo que en la literatura existen diversos términos y definiciones para referirse al dolor lumbar en la embarazada, entre ellos dolor de espalda baja, dolor de la cintura pélvica, dolor lumbar, dolor lumbosacro y dolor pélvico posterior (7).

El dolor lumbopélvico aparece entre las 22 y 36 semanas de gestación, afecta a la cintura pélvica, dificultando la bipedestación prolongada, caminar y sentarse. Esta patología dolorosa está relacionada con un aumento de cifosis dorsal, de lordosis cervical, antepulsión de hombros, hiperlordosis lumbar, anteversión pélvica y rotación externa de la articulación coxofemoral. Entre los factores de riesgo para padecer lumbalgia durante el embarazo figuran con evidencia fuerte el trabajo estresante, dolor lumbar previo y sedentarismo y con evidencia débil el peso, peso fetal, tabaquismo, epidural y parto prolongado.

Los tratamientos conservadores para la lumbalgia incluyen reposo, analgesia y educación, pero el tratamiento en embarazadas es más complejo y limitado, optimizando alternativas terapéuticas no farmacológicas ni invasivas, se puede dividir en preventivo o terapéutico dependiendo del estado general de la embarazada y el mes de gestación en el que se encuentre.

El reposo de más de dos días para el dolor lumbar no tiene fundamento científico, prolonga la discapacidad en la embarazada, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la mayoría de autores promueven la práctica de ejercicios físicos y técnicas de relajación como medidas de reducción de la lumbalgia durante el embarazo; en cambio, para otros autores, la acupuntura y los cinturones pélvicos tienen una evidencia más fuerte que el ejercicio en general y los ejercicios de estabilización específicos, y una evidencia más limitada la gimnasia acuática, la relajación muscular progresiva y el yoga.

La mayoría de la evidencia coincide en destacar estas modalidades que han resultado ser seguras y eficaces: el uso de cinturones pélvicos, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), terapia de manipulación espinal, la acupuntura, la hidroterapia, la osteopatía y el yoga. Por el contrario, para el pilates, existen pocas pruebas para indicar que mejorar la salud perinatal de las gestantes. En ese sentido, cabe destacar los beneficios resultantes de la práctica de ejercicios de fortalecimiento abdominal (kinesioterapia) y estiramientos musculares de *Stretching Global Activo* (SGA), incluyendo una marcada reducción del dolor lumbopélvico.

Aunque el ejercicio es una técnica de tratamiento propia en fisioterapia, la matrona es la encargada de la profilaxis obstétrica y de la preparación pre y postparto, aunque es cierto que el fisioterapeuta también está abordando la prevención y el tratamiento de múltiples afecciones de la mujer (8).

La presentación clínica del DLP durante el embarazo varía ampliamente. Se observa que la localización más frecuente es a nivel sacro y glúteo, descrito como profundo, careciendo de distribución radicular. Además, esta localización muchas veces difiere en el curso del embarazo, cambiando desde lumbar a sacro. La intensidad del dolor frecuentemente es moderada, aunque también pueden ser severa e incapacitante.

El grado de discapacidad asociado al DLP en el embarazo en la mayoría de los casos es moderado, y en un 20 % se clasifica como severo, interfiriendo con la vida laboral, el sueño, la vida sexual y las actividades de la vida diaria (AVD). Dentro de ellas las más comunes son: girar en la cama, estar de pie o sentada por mucho tiempo, caminar, agacharse, subir y bajar escalas y realizar quehaceres del hogar, generando una menor calidad de vida durante el embarazo.

La mayoría de las embarazadas con DLP no buscan ni usan tratamientos para el dolor, lo que sugiere una gran necesidad de adoptar modalidades de intervención efectivas basadas en las causas y examen clínico. Se prefieren actividades educacionales y realización de ejercicios aeróbicos y de estabilización, tanto de forma supervisada como en el hogar. Existe evidencia de moderada calidad que sugiere que el ejercicio reduce la intensidad del dolor, mejora la discapacidad funcional y reduce el número de ausencias laborales por enfermedad, especialmente durante la segunda mitad del embarazo.

Generalmente las mujeres con DLP se recuperan dentro de los 3 meses postparto, dado que los cambios biomecánicos y hormonales se revierten en gran medida. Sin embargo, los estudios han demostrado que el dolor persiste en un 75% de los casos a los 3 días postparto; un 54 % a los 90 días y un 8 – 20 % a los 2 a 3 años.

Los factores asociados son muy similares a los del embarazo: edad materna, paridad, IMC alto, tabaco, historia previa de DLP, malas condiciones de trabajo y falta de ejercicio. Esta condición limita las AVD y afecta la calidad de vida, específicamente asociado a falta de sueño, depresión postparto, fatiga, ansiedad, y limitaciones físicas como levantar o cargar objetos.

Dado que pocas mujeres se recuperan del DLP a los 3 meses postparto, aquellas que todavía lo presentan, se consideran en riesgo de dolor persistente, implicando un mayor nivel de catastrofismo, kinesiofobia y baja capacidad física. Por lo que es fundamental un enfoque biopsicosocial de evaluación y tratamiento durante el embarazo (2). En una revisión sistemática, en este caso D. Casagrande *et al.* citados en García Valiente M (9):

> "proponen tres escalones de tratamiento para el dolor lumbar y el dolor de la cintura pélvica. En primer lugar, hablan sobre el tratamiento conservador, donde exponen que el ejercicio redujo significativamente el dolor lumbar y la discapacidad en las pacientes embarazadas, al igual que sugieren que la acupuntura redujo el dolor de la cintura pélvica de forma más eficaz que el ejercicio. En el segundo escalón, el tratamiento farmacológico, se propone el acetaminofeno como analgésico de primera elección. Por último, el tratamiento quirúrgico se propone como tercer escalón de tratamiento realizándose de forma limitada e implicando gran coordinación entre el cirujano ortopédico y el obstetra." (p. 21) *(Figura 4)*

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (AGOG), sugiere algunas prácticas sencillas con el fin de evitar la lumbalgia en el periodo de embarazo:

- Uso de zapatos con buen soporte para el arco: los zapatos planos generalmente brindan poco apoyo. Los tacones altos pueden predisponer a la pérdida del equilibrio.
- Utilización de un colchón firme: este tipo de colchón es capaz de proporcionar mayor apoyo a la espalda durante el embarazo.

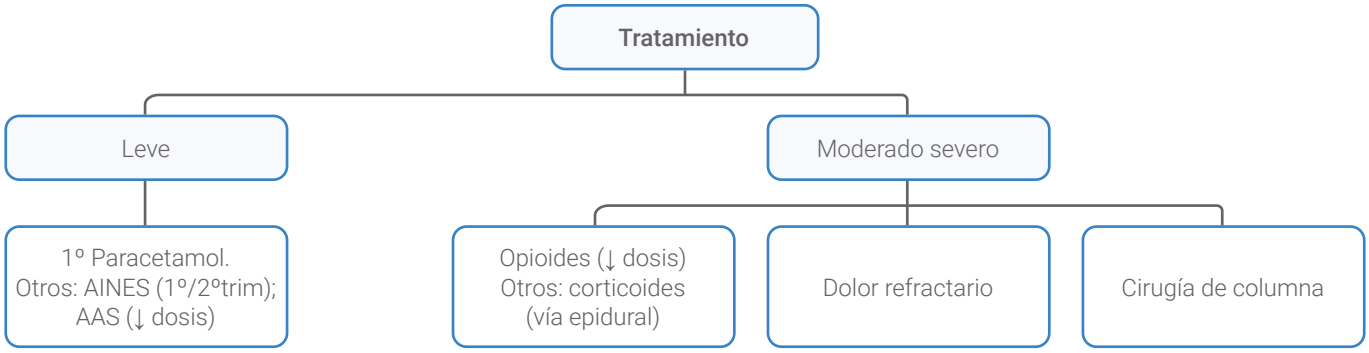

Figura 4. Tratamiento del dolor musculoesquelético en las gestantes. Tomado de: elaboración propia.

- Evitar la inclinación desde la cintura para levantar cosas: es preferible flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
- Procurar sentarse en sillas con buen respaldo o utilizar una almohada pequeña detrás de la parte baja de la espalda.
- Dormir en decúbito lateral preferiblemente: utilizar una o dos almohadas entre las piernas o debajo del abdomen. (6)

Dolor neuropático en la gestante

El dolor neuropático es frecuente durante la gestación destacando el síndrome de túnel del carpo (STC) y la meralgia parestésica.

- **Síndrome del túnel del carpo:** el síndrome del túnel carpiano es la expresión de la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, lo que se manifiesta con alteraciones de la función sensitiva y eventualmente motora de éste nervio.

  El nervio mediano está sujeto a la compresión por aumento de presión dentro de éste túnel debido a diversas condiciones que reducen el tamaño del túnel o aumentan el volumen de su contenido, tales como diabetes mellitus, alcoholismo, embarazo, hipotiroidismo, artritis reumatoide y deformidades postraumáticas, por lo que representa la neuropatía de atrapamiento más frecuente.

Estudios poblacionales reportan una prevalencia en la población general del 2 al 7 % y una relación mujer: hombre de 7:1. En embarazadas la prevalencia aumenta considerablemente a valores de 31 a 62 % cuando se hace el diagnóstico por clínica y a 7 a 43 % si se utiliza electrodiagnóstico. Comparado con la población general, las pacientes embarazadas tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de desarrollar STC. La prevalencia va aumentando al avanzar el embarazo, describiéndose un 11 % en el primer trimestre, un 26 % en el segundo trimestre y un 63 % en el tercer trimestre.

Los síntomas clásicos del STC son el adormecimiento, parestesias y dolor en la cara palmar del pulgar, índice, dedo medio y la mitad radial del 4to dedo. Eventualmente el dolor se puede irradiar a proximal (antebrazo y brazo). Típicamente ocurren síntomas por la noche, lo que despierta a la paciente y la incita a sacudir las manos para tratar de aliviar las molestias. Los síntomas también pueden ser exacerbados con movimientos repetitivos de la mano. Las pacientes pueden referir torpeza motora de las manos, con caídas de objetos o menor habilidad para destrezas finas, atribuible a la disminución de la sensibilidad (10).

Al examen físico puede constatarse hipoestesia en el territorio de nervio mediano. A medida que la enfermedad progresa puede existir debilidad muscular del pulgar (abductor y oponente) y en los casos más severos, atrofia de la eminencia tenar. Las pruebas especiales que se aplican son Tinel, Phalen y compresión carpiana de las cuales ésta última tendría la mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. *(Ver figura 5)*

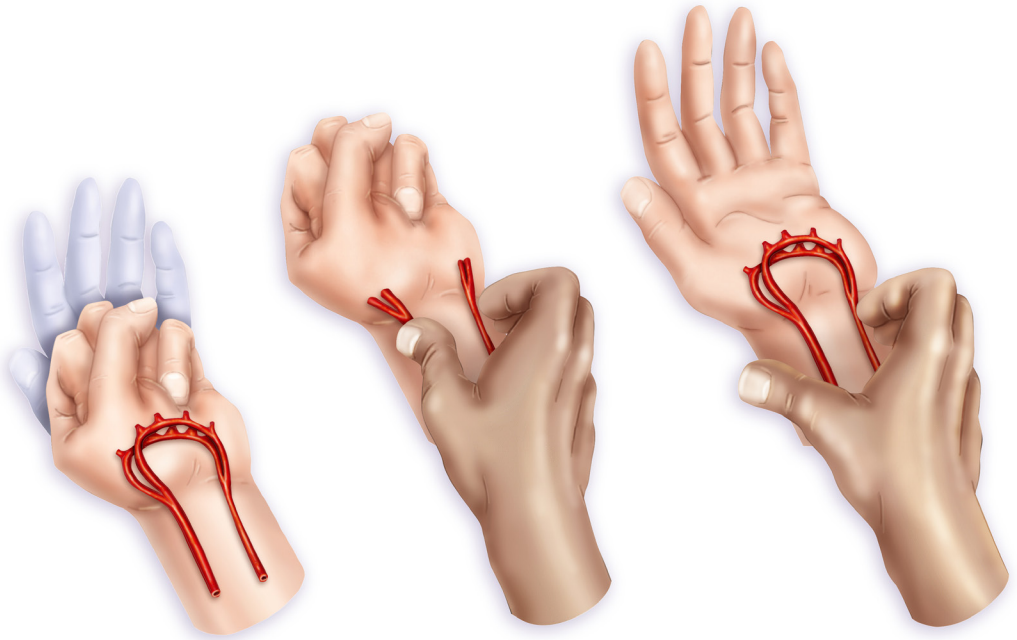

Figura 5. Maniobra de *Phalen* para explorar el territorio de inervación del nervio mediano. Tomado de: elaboración propia.

En general, el STC del embarazo es de curso benigno y tiende a resolverse posterior al parto; en el 50 % de los casos en un año, y en un 75% a los 3 años. Estas pacientes tienen una probabilidad de mejoría de los síntomas 3 a 4 veces mayor que la población general. Igualmente, la repercusión funcional tiende a ser leve, comprometiendo principalmente ámbitos como vestuario, escritura y aseo menor.

Por otra parte, se ha observado que aquellas pacientes con inicio de los síntomas en el 1er o 2do trimestre tienen peor pronóstico funcional, con mayor gravedad de síntomas, interferencia en actividades de vida diaria, alteraciones laborales y una necesidad de tratamiento más intensivo.

El estudio electrodiagnóstico considera la neuroconducción del nervio mediano y la electromiografía. La ecografía también tiene un rol en el diagnóstico del STC. El engrosamiento del nervio mediano, el aplanamiento del nervio dentro del túnel y el arqueamiento o curvatura del retináculo flexor son todas características de diagnóstico de STC a la ecografía.

Dependiendo de la severidad del cuadro, existen distintas opciones terapéuticas. El tratamiento farmacológico del dolor neuropático por STC en la población general habitualmente incluye opioides y neuromoduladores (pregabalina). Dado que la mayoría de los fármacos están contraindicados en el embarazo, esta opción terapéutica queda eliminada. Se ha utilizado suplementos de la vitamina B6 (piridoxina) y diuréticos para aliviar los síntomas del STC, pero no hay evidencia suficiente que recomiende esta indicación.

En pacientes embarazadas con STC leve, se recomienda el tratamiento basado en el uso de férulas nocturnas, reeducación postural y terapia física. Se describe que más del 80 % de las pacientes embarazadas refieren alivio sintomático considerable con el uso de las férulas, junto con mejoría de la calidad del sueño. Las medidas posturales tienen por objetivo disminuir la presión sobre la muñeca. Se debe educar a las pacientes en no dormir con la cabeza sobre su mano o muñeca, tomar los objetos con todos los dedos de la mano y no con 2 o 3 dedos, evitar actividades repetitivas de la mano, hacer ejercicios de movilizaciones de los tendones flexores.

En pacientes con STC moderado a severo se puede ofrecer la infiltración del túnel del carpo con corticoides. En embarazadas con STC este tratamiento ofrece alivio sintomático temporal, con mejoría clínica y de los estudios electrodiagnósticos. Las infiltraciones parecen especialmente útiles en aquellos casos severos en los que una búsqueda electrofisiológica detallada permite poner en evidencia importantes bloqueos de conducción. Según la respuesta clínica se podría repetir el procedimiento cada 4 – 6 semanas.

El tratamiento definitivo sigue siendo la descompresión quirúrgica, pero en embarazadas se reserva solo para casos excepcionales en los que los otros tratamientos han fallado y el cuadro es muy severo, debido a que en general tiende a resolverse con el parto y a que la mayoría de las pacientes rechazan una intervención quirúrgica. De todas formas, es una cirugía segura, con uso de anestesia regional y sin potencial de daño sobre el feto (11).

El tratamiento del síndrome del túnel carpiano tiene un doble objetivo:

- Recuperar la función normal previa para la vida cotidiana y profesional.
- Prevenir la lesión nerviosa y la atrofia muscular con la consiguiente pérdida de fuerza.

Si se detecta el síndrome del túnel del carpo, se puede tratar fácilmente. Las opciones terapéuticas dependen de la severidad y la duración de los síntomas, de la etiología y de las expectativas del paciente.

Las opciones de tratamiento conservador incluyen:

- Medidas farmacológicas como antiinflamatorios no esteroideos (AINE), diuréticos, corticoesteroides vía oral, vitaminas, anticonvulsivantes, infiltraciones del túnel carpiano como esteroides o progesterona, analgésicos locales y capsaicina.
- Medidas posturales rehabilitadoras como férulas nocturnas, iontoforesis, ultrasonidos y modificación ergonómica de la actividad profesional.

Para los casos moderados o severos, el tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. La liberación del túnel carpiano es un procedimiento quirúrgico en el que se corta el ligamento que está ejerciendo presión sobre el nervio (12).

- **Meralgia parestésica:** la meralgia parestésica (MP) es una mononeuropatía por atrapamiento que genera dolor, parestesias y pérdida de la sensibilidad en el territorio del nervio cutáneo lateral del muslo (NCLM).

A pesar de que se han identificado varios factores contribuyentes, la causa de su forma idiopática, se mantiene sin aclarar. De estos factores, los más frecuentes son: diabetes mellitus, obesidad, embarazo, tumores pélvicos, compresiones externas, uso de ropa y cintos apretados.

Se pueden considerar dos grandes formas, una idiopática (metabólica o mecánica) y otra iatrogénica (trauma o cirugía). La forma idiopática no tiene afinidad por sexo, aparece en la edad media de la vida, aunque se ha reportado en cualquier grupo de edad, y se manifiesta de forma unilateral, el 20 % puede ser bilateral. También se ha publicado una posible forma familiar (13).

El abordaje terapéutico correcto de la MP consiste en tratar las causas y modificar los factores de riesgo que generan la compresión. La mayoría de los pacientes con sintomatología leve o moderada, resuelven con tratamiento conservador. No obstante, en casos con dolor y limitación funcional severas, el bloqueo nervioso con lidocaína o bupivacaína más esteroides, es efectiva por períodos prolongados. En los casos que no mejoren con ninguna de las modalidades de tratamiento conservador, la descompresión o la ablación quirúrgica está indicada.

En el 80 % de los casos, los síntomas son unilaterales, presentándose hormigueo, entumecimiento y dolor en la zona lateral del muslo. Los factores que contribuyen a que aparezca en la gestante es el aumento del perímetro abdominal y la hiperlordosis lumbar (14). *(Ver figura 6)*

Dolor crónico en la gestante y riesgos/ beneficios de la medicación

El dolor crónico en la gestante tiene el riesgo de no ser tratado adecuadamente debido en parte a no disponer de guías clínicas ni estudios con evidencia científica para su control. Esta situación supone un reto para el especialista, que tendrá que aportar los mayores beneficios a la madre con los menores riesgos para el feto debido a la posible teratogenicidad de los fármacos utilizados. Por ello, es aconsejable ajustar las dosis de fármacos de forma individualizada, utilizando las menores dosis de fármacos precisas que controlen el dolor y asociando en lo posible terapias no farmacológicas.

La mayoría de los fármacos utilizados para controlar el dolor en estas pacientes no se han visto relacionados con el aumento del número de abortos. Sí que se aconseja evitar durante el primer trimestre los AINES y opioides por el pequeño riesgo de malformación que se ha asociado a ellos. Por otra parte, también el uso continuo de opioides podría incrementar el riesgo de partos prematuros o preeclampsia.

Son fármacos seguros durante todo el periodo gestacional, el paracetamol y los triptanes, siendo el sumatriptan el más seguro de ellos por el mayor número de estudios disponibles que lo avalan.

Al final de la gestación es preferible evitar la AAS y AINES por el mayor riesgo de sangrado, así como el cierre prematuro del DA en el caso de los AINES. El uso de opioides al final de la gestación también se ha visto asociado con el síndrome de abstinencia del recién nacido. Sin embargo, el uso continuado durante la gestación de opioides no se ha asociado a un incremento del riesgo fetal.

Por motivos éticos no se realizan ECA en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Por ello, la información relativa a la seguridad de los fármacos en el embarazo o en el periodo de lactancia se obtienen principalmente de registros de casos y estudios de casos y controles, por lo que puede ser una información con un menor nivel de evidencia.

La experiencia del uso de tratamientos para el dolor neuropático periférico en el embarazo y el periodo de lactancia proviene de pacientes con epilepsia o depresión. No se puede asegurar que ningún fármaco sea totalmente seguro. En caso de necesidad se recomienda usar el menor tiempo posible y a la menor dosis posible (11).

A continuación, se relacionan las particularidades de los principales fármacos analgésicos durante el embarazo y la lactancia:

Amitriptilina

- **Embarazo:** datos sobre su seguridad en el embarazo son controvertidos. Algunos datos sugieren una posible relación con defectos craneofaciales y de extremidades, pero otros estudios no han confirmado estos hallazgos. Si se administran durante el tercer trimestre se puede producir síndrome de abstinencia neonatal u otros efectos anticolinérgicos propios de estos fármacos. Por tanto, durante el embarazo utilizar solo si existe una clara relación beneficio/riesgo favorable, con un control ecográfico si se administra en el primer trimestre y especial atención del neonato, si se administra en el tercero. Clasificación según la *Food and Drug Administration (FDA)*: primer trimestre C, tercer trimestre D.
- **Lactancia:** la amitriptilina se detecta en la leche materna. Debido a la posibilidad de que la amitriptilina cause reacciones adversas graves en los lactantes, la decisión de continuar o no con la lactancia o el tratamiento deberá hacerse teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio de la amitriptilina para la madre.

Diagnóstico	Tratamiento	Si no hay mejoría tras parto
• Historia clínica: (hormigueo, entumecimiento y dolor en la zona lateral del muslo) • Exploración física: test neurológico (alteración función sensitiva y conservada función motora)	• Amitriptilina: infiltración anestésico local en ligamento inguinal • Parches de lidocaína	Cirugía

Figura 6. Diagnóstico y tratamiento de la meralgia parestésica de la gestante. Tomado de: Tech (s.f.)

Gabapentina

- **Embarazo:** no existen datos suficientes sobre la utilización de gabapentina para el dolor neuropático en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. No debería utilizarse durante el embarazo. FDA: C.
- **Lactancia:** se excreta por la leche materna. Se desconoce el efecto sobre el lactante. Sopesar riesgo/beneficio.

Pregabalina

- **Embarazo:** no existen datos suficientes sobre la utilización de pregabalina para el dolor neuropático, en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. No debería utilizarse durante el embarazo. FDA: C.
- **Lactancia:** se excreta por la leche. Evitar.

Duloxetina

- **Embarazo:** no hay experiencia. Toxicidad embrionaria en animales. Su uso en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, puede producir hipertensión pulmonar persistente en el neonato. Su toma cerca del parto puede provocar la aparición de síndrome de retirada en el neonato. Evitar. FDA: C.
- **Lactancia:** se excreta por la leche. Evitar.

Tramadol

- **Embarazo:** no se dispone de pruebas suficientes acerca de la seguridad de tramadol en el embarazo humano. Por tanto, no debe usarse tramadol durante el embarazo. Administrado antes o durante el parto, tramadol no afecta la contractibilidad uterina. En el neonato puede inducir alteraciones de la frecuencia respiratoria, que en general no tienen relevancia clínica. El uso crónico durante el embarazo puede dar lugar a síntomas de abstinencia neonatal. FDA: C.
- **Lactancia:** aproximadamente un 0,1 % de la dosis materna se secreta a la leche. Se recomienda no administrar durante el período de lactancia. Tras la administración de una dosis única de tramadol, normalmente no es necesario interrumpir la lactancia.

Morfina

- **Embarazo:** la morfina debe evitarse en lo posible durante el embarazo. No es teratógena, pero los hijos nacidos de madres con tratamiento crónico pueden presentar síntomas de abstinencia. Durante el parto no se recomienda su uso, ya que actúa sobre las contracciones uterinas, retrasándolo. Los recién nacidos, cuyas madres reciben opioides durante el parto, presentan signos de depresión respiratoria. FDA: C.
- **Lactancia:** se excreta por la leche. Evitar en lo posible.

Oxicodona

- **Embarazo:** no hay experiencia (evitar o sopesar riesgo/beneficio). No recomendado por el fabricante. La administración a largo plazo de oxicodona durante el embarazo puede causar síntomas de abstinencia en el recién nacido. Si se administra durante el parto, la oxicodona puede provocar depresión respiratoria en el recién nacido. Clasificado como FDA: B.
- **Lactancia:** se excreta por la leche. Evitar.

Crema de capsaicina 0,075 %

- **Embarazo:** no hay datos suficientes. Valorar riesgo/beneficio. Puede administrarse durante el embarazo según criterio médico. FDA: B.
- **Lactancia:** la cantidad teórica de capsaicina que puede recibir el lactante por la leche materna no es significativa y, teniendo en cuenta su baja toxicidad, puede considerarse improbable que la capsaicina pueda causar efectos adversos al mismo. Puede administrarse durante la lactancia según criterio médico.

Parche de capsaicina 8%

- **Embarazo:** hay datos limitados relativos al uso de capsaicina en mujeres embarazadas. Según la farmacocinética observada en seres humanos, que demuestra que la exposición sistémica a la capsaicina es baja y transitoria, la probabilidad de que el parche de capsaicina aumente el riesgo de anomalías del desarrollo cuando se administra a mujeres embarazadas es escasa. No obstante, se debe tener cuidado cuando se prescriba este medicamento a mujeres embarazadas. FDA: B.
- **Lactancia:** se desconoce si la capsaicina o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales muestran que capsaicina/metabolitos se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con el parche de capsaicina al 8 %.

Parche lidocaína 5 %

- **Embarazo:** no hay datos suficientes. Valorar riesgo/beneficio. FDA: B.
- **Lactancia:** se excreta en leche materna en pequeñas cantidades. Precaución.

Conclusiones

Durante la gestación, siguen siendo las cefaleas primarias las más frecuentes y prevalentes, concretamente la migraña. Esta, experimenta una mejoría relacionada con factores hormonales, aunque este hecho no es tan evidente en las formas con aura.

La prevalencia de DLP en el embarazo es alta y se mantiene en un alto porcentaje posterior al parto, asociado significativamente con un mayor grado de discapacidad, afectando las actividades domésticas, de la vida diaria y actividad sexual.

El STC tiene alta prevalencia en el embarazo con una alta tasa de subdiagnóstico debido a que la mayor parte de las pacientes no consultan. La infiltración con corticoides en el STC del embarazo logra mejorar los síntomas, la funcionalidad y calidad de vida, además de evitar o retrasar la cirugía.

La meralgia parestésica es un reto médico, debido a que puede simular enfermedades comunes como los desórdenes lumbares. Tiene un curso autolimitado y el diagnóstico se realiza basado en el conocimiento adecuado de la anatomía, la fisiopatología, los factores etiológicos y los elementos clínicos. El tratamiento, aunque con falta de consenso, ofrece resultados favorables en la mayoría de los pacientes.

Referencias bibliográficas

1. González-García N, Díaz de Terán J, López-Veloso AC, Mas-Sala N, Mínguez-Olaondo A, Ruiz-Piñero M, *et al.* Cefalea: embarazo y lactancia. Recomendaciones del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN). Neurología. 2019. https://doi.org/10.1016/j.nrl.2018.12.003.
2. Venegas M, Fuentes B, Carrasco B, Cohen D, Castro M, Lemus C, *et al.* Dolor lumbopélvico asociado a discapacidad durante el tercer trimestre de embarazo y su evolución posterior al parto. Rev Chil Obstet Ginecol 2018; 83(6): 567-85.
3. Ministerio de Salud de Perú. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la migraña. 2018. [Internet] https://www.incn.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/2018-Guia-de-practica-clinica-para-el-diagnostico-y-tratamiento-de-la-migraña-version-corta.pdf
4. Cuellar Rodriguez S. Migraña. Panorama Actual Med. 2018; 42(415): 1-30.
5. Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología (SANCE). Guía Oficial de Cefaleas 2019. [Internet] http://www.saneurologia.org/wp-content/uploads/2019/03/Guia_Cefaleas_san-2019.pdf
6. Sequeira-Calderón D, Sánchez-Lydna G, Sandoval-Loría DF, Murillo-Saviano JA, Sánchez-Más ES. Lumbalgia en el embarazo: abordaje para el médico general. Revista Clínica de la Escuela de Medicina UCR-HSJD 2019; 9(5): 34-8.
7. Urturbia V. Lumbago en el embarazo. Rev Hosp Clín Univ Chile 2018; 29: 7-15.
8. Fajardo-Hervás B, Oneto-Fernández LP, Parrado-Soto MB. Prevención y tratamiento del dolor lumbopélvico durante el embarazo desde una visión multidisciplinar. Paraninfo Digital, 2018; XII(28): e034 http://www.index-f.com/para/n28/e034.php
9. García Valiente M. Ortobstetricia: tratamiento de la patología ortopédica en la paciente embarazada. ¿Afecta la vía del parto la patología previa de columna? [Tesis de grado] Universitat Jaume I. 2018
10. Cerda L, Contreras S. Síndrome de túnel carpiano en el embarazo. Revisión de literatura y presentación de un caso clínico. [Internet] https://www.researchgate.net/publication/328581091. Citado 29 octubre 2018.
11. Soria Arbilla A, Graz Zugasti M. Fisioterapia en el sindrome del tunel carpo. [Internet] https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/fisioterapia-en-el-sindrome-del-tunel-carpiano. Citado 20 mayo 2019.
12. Grünenthal Health. Dolor crónico primario Síndrome del túnel carpiano. [Internet] https://www.dolor.com/es-es/para-sus-pacientes/otros-recursos/tunel-carpiano. Citado 19 agosto 2019.
13. Hernández-González EH, Mosquera-Betancourt G. Meralgia parestésica. Rev. Arch Med Camagüey 2019; 23(1). [Internet] http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552019000100131
14. Moya-Riera J, Rodríguez-Quintosa J, Fernández-Moya R. Clases magistrales en el tto multidisciplinario del dolor. L'Hospitalet de Llobregat. España. Editora EIU International. 2020.
15. Gálvez Mateo R. Guía de Práctica Clínica sobre el Tratamiento Farmacológico del Dolor Neuropático Periférico en Atención Primaria (2018). [Internet] https://www.asociacionandaluzadeldolor.es/wp-content/uploads/2018/03/guia-dolor-neuropatico.pdf